

Sparsentan a rýchla, udržaná redukcia proteinúrie pri IgA nefropatii v reálnej praxi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.09.2026

Proteinúria patrí pri IgA nefropatii (IgAN) medzi najdôležitejšie modifikovateľné ukazovatele rizika progresie chronickej choroby obličiek. Súčasná stratégia preto začína optimalizovanou podpornou liečbou vrátane kontroly krvného tlaku, inhibície systému renín-angiotenzín (RAS) v maximálne tolerovanej dávke a podľa vhodnosti aj inhibítora SGLT2. Pri pretrvávajúcej proteinúrii môže prichádzať do úvahy sparsentan, ktorý v jednej molekule kombinuje antagonizmus endotelínového receptora typu A a receptora AT1 pre angiotenzín II.

Nová multicentrická retrospektívna štúdia zo Španielska sledovala účinok sparsentanu v bežnej klinickej praxi. Jej význam spočíva v tom, že väčšina pacientov už dostávala modernú podpornú liečbu vrátane inhibítora SGLT2. Zároveň však ide o malú nekontrolovanú kohortu, takže výsledky opisujú asociáciu po nasadení lieku a nemožno z nich samostatne dokázať jeho kauzálny účinok ani dlhodobý vplyv na zlyhanie obličiek.

Čo štúdia sledovala

Práca *Twelve-month real-world outcomes of sparsentan in a multicenter Spanish IgA nephropathy cohort* bola publikovaná v časopise *Clinical Kidney Journal*. Išlo o retrospektívnu multicentrickú analýzu pacientov s biopsiou potvrdenou IgAN, ktorí začali sparsentan mimo klinického skúšania a mali najmenej 3 mesiace sledovania.

- Do analýzy bolo zaradených **41 pacientov**; medián veku bol 42 rokov.
- Medián vstupného eGFR bol **44 ml/min/1,73 m²**, teda išlo o kohortu s už zníženou funkciou obličiek.
- **95 %** pacientov užívalo pri začatí sparsentanu aj inhibítor SGLT2.
- Všetci pacienti mali biopsiou potvrdenú IgAN a liečba bola podaná v rutinej praxi, nie v randomizovanom skúšaní.
- Primárnym cieľom bol podiel pacientov s redukciou proteinúrie o **viac než 50 %** po 3 mesiacoch.

V dostupnom abstrakte nie je uvedený počet pacientov s údajmi v každom časovom bode. Pri 6- a 12-mesačných výsledkoch preto treba počítať s menšími podskupinami a s vyššou neistotou odhadu.

Rýchly pokles proteinúrie

Medián proteinúrie klesol z **1 163 mg/24 h** na **772 mg/24 h** po 3 mesiacoch. Autori uvádzajú medián relatívnej redukcie **44,1 %** a 51 % pacientov dosiahlo pokles o viac než 50 %.

Časový bod	Výsledok	Interpretácia
Vstup	Medián 1 163 mg/24 h	Východisková proteinúria pred sparsentanom
3 mesiace	Medián 772 mg/24 h; redukcia 44,1 %	51 % pacientov dosiahlo redukcii o viac než 50 %
6 mesiacov	Medián redukcie 46,9 %	Efekt pretrvával v dostupnej podskupine
12 mesiacov	Medián redukcie 38,9 %	Efekt pretrvával, s väčšou variabilitou a menším počtom pozorovaní

Číselný pokles po 3 mesiacoch je klinicky zaujímavý, najmä preto, že 95 % pacientov už užívalo inhibítor SGLT2. Porovnanie s účinkom samotnej RAS blokády alebo so sekvenčným pridaním inej liečby však štúdia neumožňuje.

Funkcia obličiek a bezpečnosť

Funkcia obličiek podľa abstraktu zostala počas sledovania stabilná napriek mierne až stredne zníženému vstupnému eGFR. Toto pozorovanie je upokojujúce, ale 12 mesiacov a nekontrolovaný dizajn nestačia na spoľahlivé určenie skutočného sklonu eGFR ani na preukázanie prevencie zlyhania obličiek.

Autori nepozorovali **klinicky významnú hyperkaliémiu ani závažné nežiaduce udalosti**. Tento záver

neznamená, že monitorovanie nie je potrebné. Pri sparsentane treba individuálne sledovať krvný tlak, objemový stav, kreatinín alebo eGFR, draslík a podľa platných informácií o lieku aj pečenné testy. Pri poklese tlaku, akútnom zhoršení funkcie obličiek alebo objemovej deplecii je potrebné prehodnotiť súbežnú liečbu a hydratáciu pacienta.

Ako výsledky zapadajú do randomizovaných dát

Randomizované skúšanie PROTECT porovnávalo sparsentan s maximálne titrovaným irbesartanom u dospelých pacientov s IgAN a pretrvávajúcou proteinúriou napriek RAS blokade. Randomizovaných bolo 406 pacientov (po 203 v každej skupine). Po 110 týždňoch bola proteinúria pri sparsentane približne o 40 % nižšia než pri irbesartane (pomer geometrických priemerov 0,60; 95 % IS 0,50–0,72). Chronický sklon eGFR (týždne 6–110) bol **–2,7 oproti –3,8 ml/min/1,73 m² za rok** (rozdiel 1,1; 95 % IS 0,1–2,1; $P = 0,037$), zatiaľ čo celkový 2-ročný sklon tesne nedosiahol významnosť (rozdiel 1,0; 95 % IS –0,03 až 1,94; $P = 0,058$). Kompozitný ukazovateľ zlyhania obličiek dosiahol 18 (9 %) pacientov pri sparsentane oproti 26 (13 %) pri irbesartane – relatívne riziko 0,7 (95 % IS 0,4–1,2), teda bez štatisticky jednoznačného rozdielu.

Systematický prehľad a meta-analýza z roku 2024 zahŕňali **tri štúdie s celkovo 884 pacientmi** s IgAN alebo fokálnou segmentovou glomerulosklerózou, nie iba pacientov s IgAN. V porovnaní s irbesartanom bol sparsentan spojený s priaznivejším UPCR (pomer percentuálnej redukcie 0,66; 95 % interval spoľahlivosti [IS] 0,58–0,74), častejšou kompletnou remisiou proteinúrie (relatívne riziko 2,57; 95 % IS 1,73–3,81) a čiastočnou remisiou (relatívne riziko 1,63; 95 % IS 1,40–1,91). Rozdiel v eGFR oproti irbesartanu nebol štatisticky významný a hypotenzia bola častejšia pri sparsentane (relatívne riziko 2,02; 95 % IS 1,30–3,16).

Meta-analýza teda podporuje najmä antiproteinurický účinok. Pri interpretácii renálnych „hard“ endpointov treba zohľadniť malý počet štúdií, rozdielne populácie, odlišné definície remisie a dĺžku sledovania.

Praktické limity štúdie z reálnej praxe

- Retrospektívny dizajn prináša riziko výberového skreslenia a chýbajúcich údajov.
- Bez kontrolnej skupiny nemožno oddeliť účinok sparsentanu od prirodzenej variability proteinúrie, súbežnej liečby a zmien životného štýlu.
- Pacienti, ktorí mali dlhšie sledovanie, nemuseli byť reprezentatívni pre všetkých zaradených pacientov.
- Pokles proteinúrie je dôležitý náhradný ukazovateľ, ale sám osebe nenahrádza dlhodobé údaje o sklone eGFR, zlyhaní obličiek a mortalite.

Záver pre klinickú prax

V multicentrickej španielskej kohorte bol sparsentan spojený s rýchlym poklesom proteinúrie po 3 mesiacoch a s pretrvávajúcim účinkom do 12 mesiacov. Výsledok je pozoruhodný najmä v prostredí, kde väčšina pacientov už užívala inhibitor SGLT2 a mala znížené vstupné eGFR. Nejde však o dôkaz, že sparsentan sám spôsobil celý pozorovaný efekt, ani o dôkaz, že krátkodobá stabilita eGFR znamená prevenciu zlyhania obličiek.

V praxi má rozhodnutie o sparsentane vychádzať z celkového rizika progresie IgAN, stupňa proteinúrie, krvného tlaku, funkcie obličiek, objemového stavu, súbežnej liečby, kontraindikácií a dostupnosti lieku. Po nasadení je potrebné plánované klinické a laboratórne sledovanie, predovšetkým krvného tlaku, kreatinínu alebo eGFR, draslíka a pečenných testov.

Súvisiace články na portáli

- [Sparsentan so SGLT2 inhibítorom pri IgA nefropatii: SPARTACUS a PROTECT OLE](#)
- [Kompletná remisia proteinúrie v štúdii PROTECT](#)
- [Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025](#)

Zdroj: García-Carro C, Rodríguez-Moreno A, Cordero L, Pérez-Gómez MV, Rusiñol HM, Pasache E, Morales A, Zamora R, Parra D, Villa J, Guillén-Olmos E, Coll-Brito V, Álvarez Á, Bordignon J, Arcal C, Gracia O, Delgado P, Soler MJ, Sánchez-Fructuoso AI. Twelve-month real-world outcomes of sparsentan in a multicenter Spanish IgA nephropathy cohort. *Clinical Kidney Journal*. 2026;19(9):sfag298. doi:10.1093/ckj/sfag298. DOI; PubMed PMID

42746507.

Ďalší zdroj: Abo Elnaga AA, Alsaied MA, Elettrey AM, Ramadan A, Abouzid M, Shetta R, Al-Ajlouni YA. Safety and efficacy of sparsentan versus irbesartan in focal segmental glomerulosclerosis and IgA nephropathy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Nephrology*. 2024;25(1):316. doi:10.1186/s12882-024-03713-9. PMID 39333921. [DOI](#); [PubMed](#); [Plný text v PubMed Central](#).

Randomizované dáta PROTECT: Rovin BH, Barratt J, Heerspink HJL, et al. Efficacy and safety of sparsentan versus irbesartan in patients with IgA nephropathy (PROTECT): 2-year results from a randomised, active-controlled, phase 3 trial. *The Lancet*. 2023;402:2077–2090. doi:10.1016/S0140-6736(23)02302-4. [PubMed](#).

Bibliografické údaje a hlavné výsledky boli overené 17. septembra 2026 cez PubMed/eutils, Crossref a otvorený fulltext meta-analýzy. Text je odborným informačným materiálom a nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=sparsentan-realna-prax-iga-nefropatia-12-mesiakov> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.